EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93706
SERVICIO : UNIDAD EMERGENCIAS
FECHA : 2024-09-28 14:39:04

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: AMELIA DE LAS MERCED RAMIREZ PARRA			RUN	: 6.141.381-2
F.Nac	: 16-01-1932	Edad	: 92 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: V. LA VIRGEN STA TERESA 674 *ACT*			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 27-09-2024	Fecha Egreso	: 2024-09-28 14:39:04	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	: COMUNIDAD TERAPEUTICA

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I26.9-EMBOLIA PULMONAR SIN MENCIÓN DE CORAZÓN PULMONAR AGUDO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONIA
ANGIO TAC DE TORAX 27/09/24
ESTUDIO NEGATIVO PATA TEP HASTA EL NIVEL SEGMENTARIO
CORAZON CON AUMENTO DE TAMAÑO GLOBAL . CALCIFICACIONES EN PLANO VALVULAR AORTICO
MODERADO DERRAME PLEURAL BILATERAL, ASOCIADO A CONSOLIDACIONES ATELECTASICAS DE LOS LOBULOS INFERIORES
ATEROMATOSIS CORONARIA Y AORTICA.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON AM DE HTA, USUARIA DE MCP POR BRADIARRITMIA, ICC, ALERGIAS: METOCLOPRAMIDA
FX DE PELVIS 2024
PACIENTE ACUDE CON RESULTADO CRITICO EN INFORME DE ANGIOTAC DE TORAX DEL 15/09: Tromboembolismo pulmonar agudo bilateral, con signos tomográficos de sobrecarga de cavidades
cardíacas derechas.
Cardiomegalia.
Derrame pleural bilateral.
Signos de edema intersticial.
FAMILIAR REFIERE DISNEA A ESFUERZOS, DPN, EDEMA DE MIMEBROS INFERIORES DESDE EL 13/09 APROX, ACUDE A EVALUACION CON DX DE ICC DESCOMPENSADA, SE AJUSTA TTO CRONICO CON AUMENTO DE DIURETICOS Y RESTRICCION HIDRICA CON BUENA RESPUESTA
RESCATAN RESULTADO DE ANGIOTAC CON SIGNOS DE TEP BILATERAL POR LO QUE ES TRAIDA PARA EVALUACION
AFEBRIL, HIDRATADA, EUPNEICA
SAT 98% AMBIENTAL
RR2T SS MP+ CON CREPITOS BILATERALES, MAYOR A DERECHA UMA-
ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE INDOLORO RHA+
EEII SIN EDEMA
NEUROLOGICO SIN FOCALIDAD
ANTECEDENTES:
Otros: No
Alergias: No Farmacos: No
SIGNOS VITALES:
PA: 118/64 mmHg FC: 0 x/min T°Ax: 36.6°C T°Rec: °C HGT: mg/dL Sat.: 98%
GCS: 0 ptos. FR: x/min Peso: Kg Talla: cm Score de Tal: ptos.
EXAMEN FISICO:
AFEBRIL, HIDRATADA, EUPNEICA
SAT 98% AMBIENTAL
RR2T SS MP+ CON CREPITOS BILATERALES, MAYOR A DERECHA UMA-
ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE INDOLORO RHA+
EEII SIN EDEMA
NEUROLOGICO SIN FOCALIDAD

Cabeza: Normal

Tórax: Normal

Pulmonar: Normal

Cardiaco: Normal

Abdomen: Normal

Extremidades: Normal

Neurológico: Normal

Columna: Normal

Genitales: Normal

Otros:

HIPOTESIS DIAGNOSTICA
EMBOLIA PULMONAR SIN MENCIÓN DE CORAZÓN PULMONAR AGUDO
INDICACIONES
HOSPITALIZAR EN MEDICINA AGUDOS
REPOSO ABSOLUTO
REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO
CSV CADA 6 HORAS Y HGT
O2 SOS PARA SAT > 90%
HEPARINA 5000 UDS CADA 12 HRS SC
FUROSEMIDA 40MG VO AM - 20MG VO PM
CARVEDILOL 3.125 MG CADA 12 HORAS VO
HIDRALAZINA 50MG 1/2- 1/2 VO
FERRANIM 1 COMP VO DIA
PARACETAMOL 500MG VO CADA 8 HORAS SOS
PENDIENTE RESCATAR INFORME DE ANGIOTAC
CONTROL RESIDENTE SOS

PLAN DE MANEJO:

HODOM
CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA DIA POR 7 DIAS
AZITROMICINA 500 MG VO TOMAR UN CADA DIA POR 5 DIAS
XARELTO 15 MG CAD 12 VO HORAS POR 21 DIAS
PARACETAMOL COMP 1 MG VO TOMAR CADA 8 HORAS / SOS
BROMURO DE IPATROPIO INH HACE 2 PUF CADA 6 HORAS POR 5 DIAS
VAL, POR CARDIOLOGIA
VAL. BRONCOPULMONAR.

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM
2. CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA DIA POR 7 DIAS
3. AZITROMICINA 500 MG VO TOMAR UN CADA DIA POR 5 DIAS
4. XARELTO 15 MG CAD 12 VO HORAS POR 21 DIAS
5. PARACETAMOL COMP 1 MG VO TOMAR CADA 8 HORAS / SOS
6. BROMURO DE IPATROPIO INH HACE 2 PUF CADA 6 HORAS POR 5 DIAS
7. VAL. POR CARDIOLOGIA.
8. VAL. POR BRONCOPULMONAR

OBSERVACIONES:

1. DIRECCION DOMICILIO : VILLA DOÑA JAVIERA 3 CALLE SANTA TERESA 674 , SAN CARLOS
TUTOR: HIJA -AMELIA ARAVENA , TELEFONO : 945096547
2. HOSPITALIZADA EN SERVICIO DE URGENCIA ADULTO.
3. NEUMONIA
4. POR TTO ATB EV
5.CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA DIA POR 7 DIAS , INICIO HOY DE TTO ,7 DOSIS PENDIENTES.
6. REPORTAR EN CASO DE DISNEA , EDEMA, YUGULARES INJURGITADAS

Giovanni Sánchez Troncoso
MEDICO TRATANTE
19823365-K

JEFE SERVICIO